

Guia Completa:

PRIMERAS SESIONES CON PACIENTES

Lic Agustina Rey

Escucha
activa

Vinculo
terapeutico

Intervencion
clinica

Registro

Indice de contenidos

Todo lo que vas a encontrar en esta guía

PARTE1 · TEORIA Y PRACTICA CLINICA

1. Que es la primera sesion y para que sirve
2. Los objetivos de la primera sesion
3. La escucha activa: lo más importante del primer encuentro
4. El vinculo terapeutico: como empieza a construirse
5. Preparacion antes de la sesion
6. Como abrir la primera sesion: guia de inicio
7. Que informacion relevar (y que **no** presionar)
8. Intervenciones basicas para la primera sesion
9. Dialogos modelo: como responder en situaciones
10. El manejo del silencio
11. Como cerrar la primera sesion
12. Señales de alarma a evaluar
13. Errores frecuentes y como evitarlos
14. Diferencias: adultos vs. infanto-juvenil
15. Checklist de la primera sesion

PARTE2 · DOCUMENTOS Y PLANTILLAS

- 16 Historia clinica - primera entrevista
- 17 Ficha de datos del paciente
18. Registro de motivo de consulta y objetivos
19. Diario de sesion (para la terapeuta)
20. Planilla de seguimiento sesion a sesion
- 21 Guia de preguntas para la primera entrevista

PARTE 3 - RECURSOS ADICIONALES

Entrevista inicial - Adultos
Entrevista inicial - Padres
Entrevista inicial - adolescentes
Historia clinica completa
Evaluación de riesgo - Adultos y adolescentes
Conceptualización de caso
Objetivos terapeuticos
Seguimiento de sesiones
Checklist de urgencia clinica

1. Que es la primera sesion

Definicion, funcion clinica y encuadre inicial

DEFINICION

La primera sesion es el primer encuentro formal entre el o la terapeuta y el paciente.

No es solo una “recoleccion de datos”: es el inicio del proceso terapeutico, el momento en que comienza a construirse la alianza y el espacio donde el paciente decide si quiere continuar. Todo esos puntos tienen su grado de importancia. **Importante acá: No confundir la primera sesión con recolección de datos (lo hablaremos posteriormente)**

En la primera sesion pasan tres cosas al mismo tiempo:

- El terapeuta empieza a conocer al paciente y a construir sus primeras hipotesis
- El paciente decide si quiere continuar ese proceso
- Empieza a construirse el vinculo terapeutico

Importante: No es solo el paciente quien decide continuar o no despues de la primera sesión. El terapeuta tambien tiene derecho a decidir si puede acompañar o no a ese paciente.

FUNCION CLINICA

La primera sesion cumple una funcion evaluativa y vincular al mismo tiempo. No se puede priorizar una sobre la otra sin consecuencias clinicas.

FUNCION EVALUATIVA	FUNCION VINCULAR
Conocer el motivo de consulta real	Crear un espacio de seguridad
Identificar el problema actual y su historia	Transmitir presencia y atencion genuina
Construir hipotesis diagnosticas iniciales	Validar la experiencia del paciente
Evaluar riesgo y urgencia	Escuchar sin juzgar ni apresurarse
Determinar si es la modalidad adecuada	Permitir que el paciente se sienta visto

Clave clínica: La primera sesión requiere sostener dos funciones en simultáneo: evaluar y vincular. Si priorizas la evaluación sobre el vínculo, obtenes datos pero perdes de vista el vinculo con el paciente. Si priorizas el vínculo y no evaluas, no tenes un norte clínico. El equilibrio es la escucha activa con objetivos claros. Eso es lo que diferencia la primera sesión de una charla o de un formulario de admisión.

2. Los tres objetivos de la primera sesion

Hacia donde ir sin perder de vista el vinculo

01

Construir la alianza terapeutica

La alianza es el **predictor mas robusto del resultado terapeutico**, independientemente del enfoque. En la primera sesion no se construye toda la alianza, pero se sientan sus bases: el paciente necesita sentirse escuchado, comprendido y no juzgado. Hay un otro que quizas está en su primer proceso terapeutico; que llega con dudas o prejuicios; con miedos o historias de invalidación. Por eso, es tan importante no perder de vista la escucha y la presencia. Cómo podemos construir esa alianza?

- Recibir al paciente con calidez y presencia
- Usar su propio lenguaje para referirte a lo que cuenta
- Validar antes de explorar: primero que se sienta comprendido
- Mostrar curiosidad genuina por su historia
- Ser transparente con el encuadre

02

Comprender que trae el paciente

El motivo de consulta que el paciente declara al inicio no siempre es el motivo de consulta real. A veces aparece en los ultimos diez minutos. Tu tarea en la primera sesion es escuchar lo que dice, lo que no dice, como lo dice y lo que trae en el cuerpo. Algunas señales a observar:

- Temas que evita o rodea sin nombrar directamente
- Contradicciones entre lo que dice y cómo lo dice emocionalmente

03

Recolectar informacion clinica relevante

Este objetivo siempre es el tercero, nunca el primero. La información que necesitás en esta sesión es:

- Motivo de consulta y cómo lo formula el paciente
- Historia del problema actual: cuándo empezó, qué lo desencadenó
- Intentos de solución previos y tratamientos anteriores
- Red de apoyo con la que cuenta
- Evaluación básica de riesgo (siempre, ante cualquier indicador)

Lo que NO necesitás en la primera sesión: historia de vida completa, diagnóstico cerrado, conocer todos los vínculos. Eso viene después.

Regla del 80/20 La primera sesión es 80% escucha activa y 20% evaluación. Lo que no pudiste relevar en la primera sesión, podés hacerlo en la segunda

3. La escucha activa

El recurso terapeutico mas poderoso de la primera sesion

QUE ES LA ESCUCHA ACTIVA

La escucha activa es un estado de presencia plena donde la terapeuta registra el contenido verbal, el tono emocional, el lenguaje corporal, las contradicciones y los silencios del paciente, mientras sostiene una actitud de aceptacion y curiosidad genuina. La escucha activa NO implica que el profesional no hable. Implica que cuando habla, lo hace desde lo que el paciente trajo

LOS 5 NIVELES DE LA ESCUCHA ACTIVA

N.	NIVEL	QUE OBSERVAS
1	Escuchar el contenido	Que dice el paciente. Los hechos, las situaciones, las personas involucradas.
2	Escuchar la emocion	Como se siente mientras lo cuenta. Que emocion hay debajo de las palabras.
3	Escuchar lo que no dice	Los temas que evita, las palabras que nunca menciona, los saltos en la narrativa.
4	Escuchar el cuerpo	Tension, postura, contacto visual, velocidad del habla, silencios.
5	Escuchar lo que produce en vos	La contratransferencia es informacion clinica. Que sentis vos al escucharlo.

HERRAMIENTAS DE LA ESCUCHA ACTIVA

- Reflejo simple: repetir o parafrasear lo que dijo el paciente para mostrar que escuchaste.
- Reflejo emocional: nombrar la emocion que percibis debajo de lo que cuenta.
- Clarificacion: pedir que amplie algo sin que suene a interrogatorio.
- Validacion: reconocer que lo que siente tiene sentido dado lo que vivio.
- Silencio sostenido: no llenar todos los silencios. Dejar que el paciente complete.
- Resumen parcial: sintetizar lo que fue diciendo para mostrar que seguiste el hilo.

Mito: "Escuchar activamente es no intervenir y dejar hablar al paciente." Realidad: La escucha activa es una intervenci3n en s3 misma. Cada reflejo, cada silencio sostenido, cada validaci3n es una acci3n cl3nica deliberada

Nota cl3nica: La escucha activa se deteriora cuando la terapeuta est3 pensando en su pr3xima pregunta mientras el paciente habla. Si te d3s cuenta de que est3s armando mentalmente el siguiente paso, es una se3al para volver al presente.

4. El vínculo terapeutico

Como empieza a construirse desde el primer momento

POR QUE IMPORTA TANTO

La investigación en psicoterapia muestra que la calidad de la alianza terapeutica predice el resultado del tratamiento mas que el enfoque teorico utilizado. Bordin (1979) identifico tres componentes de la alianza: **acuerdo en los objetivos, acuerdo en las tareas y el vinculo afectivo**. Los tres empiezan a definirse desde la primera sesion. El vinculo terapeutico es la base desde la cual el paciente puede arriesgarse a cambiar. Sin vinculo, las mejores tecnicas NO funcionan.

LOS TRES COMPONENTES DE LA ALIANZA (BORDIN, 1979)

- Acuerdo en los objetivos: el paciente y la terapeuta están orientados hacia lo mismo
- Acuerdo en las tareas: el paciente entiende y acepta cómo se va a trabajar
- Vínculo afectivo: hay confianza, calidez y sentido de colaboración+

Los tres empiezan a definirse desde la primera sesión, aunque ninguno queda consolidado en ese momento.

Una pregunta para hacerte al terminar la sesión:

¿Este paciente se fue sintiéndose visto? ¿O se fue sintiéndose evaluado?

ERRORES FRECUENTES EN LA PRIMERA SESIÓN

- Interrumpir al paciente para completar un formulario
- Dar “soluciones” antes de entender en profundidad qué está trayendo
- Creer que hay que intervenir antes de que haya alianza terapéutica y de conocer al paciente
- Reaccionar con sorpresa, juicio o incomodidad visible ante lo que el paciente cuenta
- Hacer varias preguntas seguidas sin esperar la respuesta de cada una
- Llenar los silencios por ansiedad propia
- No explorar ideación suicida ante cualquier indicador, por incomodidad con el tema
- Prometer resultados: "te voy a ayudar a resolver esto"
- Cerrar la sesión sin acordar cómo continuar

5 y 6. Preparacion y apertura

Antes y durante los primeros minutos de la sesion

5. PREPARACION ANTES DE LA SESION

- Si tenes datos previos (contacto inicial, derivacion, formulario), leerlos sin construir una hipotesis cerrada.
 - Revisar si hay algun dato de riesgo que debas tener presente desde el inicio.
 - Tener tu espacio ordenado, sin interrupciones posibles y con tiempo suficiente.
 - Estar abierto a que la primera sesión puede tener distintos destinos según quién llegue:
 - Puede que llegue un paciente más desbordado y que llore gran parte de la sesión: importante priorizar contención
 - Puede llegar un paciente más retraído, al cual le cueste hablar: guiar con preguntas abiertas, sin presionar
 - El paciente verborrágico que cuenta todo con detalle: importante sostener la estructura sin cortar
- La rigidez de querer que la sesión sea de cierta manera puede generar frustración y hacerte perder el momento presente.

6. COMO ABRIR LA PRIMERA SESION

Importante que la apertura a ese primer encuentro sea con presencia y calidez, marcando el tono del encuentro.

EJEMPLO DE APERTURA

TERAPEUTA

Tene en cuenta que este es un espacio tuyo: acá no hay respuestas correctas o incorrectas. Podes contarme lo que quieras al ritmo que necesites. Queres contarme sobre vos?

PACIENTE

Gracias. No se muy bien por donde empezar.

TERAPEUTA

Por donde quieras. Podes contarme que te trajo hoy aca

Evitar: *empezar directamente con preguntas cerradas.*

Preferir: *dar permiso, bajar la presión y abrir el espacio sin imponer una estructura visible.*

En pacientes retraídos, que expresan no saber por dónde empezar o que es su primer espacio terapéutico, es preferible abrir con algo más descontracturado:

"¿Querés contarme de vos?"

7. Que informacion relevar

Y que no presionar en una primera sesion

AREAS A EXPLORAR EN LA PRIMERA SESION

AREA	QUE EXPLORAR
Motivo de consulta	Que lo trae, cómo lo formula, que espera del proceso. Expectativas
Historia del problema actual	Cuando empezo, que lo desencadeno, como evolucionó.
Intentos de solucion previos	Que hizo hasta ahora, si tuvo terapia antes, que funciono o no funciono.
Red de apoyo	Con quien cuenta, si tiene vinculos de confianza.
Evaluacion de riesgo basica	Siempre preguntar por ideacion suicida, consumo de sustancias y situaciones de violencia si hay indicadores.
Motivacion y expectativas	Que espera de la terapia, si viene por decision propia.

QUE NO ES NECESARIO EN LA PRIMERA SESION

- ✗ Historia de vida completa desde la infancia.
- ✗ Formular un diagnostico cerrado y definitivo.
- ✗ Formulacion teorica completa del caso.
- ✗ Conocer todos los vinculos familiares y relacionales.
- ✗ Que el paciente 'hable de todo' si no esta listo.

Clave clinica: La primera sesion no es el unico momento para recolectar informacion

8. Intervenciones basicas

Herramientas clinicas para la primera sesion

Parafrasis

Repetir con otras palabras lo que dijo el paciente para mostrar que entendiste.

Vos decis: 'Parece que en este ultimo tiempo te sentiste muy solo frente a esa situacion.'

Reflejo emocional

Nombrar la emocion que percibis en el relato del paciente.

Vos decis: 'Mientras me contabas eso, note que habia algo de tristeza. Fue asi?'

Pregunta abierta

Preguntas que invitan a desarrollar sin direccionar la respuesta.

Ejemplos: 'Como fue eso para vos?', 'Que paso despues?', 'Y eso como te afecto?'

Validacion

Reconocer que la experiencia del paciente tiene sentido dado lo que vivio.

Vos decis: 'Tiene mucho sentido que hayas reaccionado asi. Era una situacion muy dificil.'

Pregunta de clarificacion

Pedir que amplie algo concreto sin que suene a interrogatorio.

Vos decis: 'Me quedo con una palabra que usaste, me podes contar mas sobre eso?'

Socializacion al modelo

Hacia el final de la sesion, explicar brevemente como vas a trabajar.

Vos decis: 'La idea es que trabajemos juntos entendiendo como tus pensamientos y emociones se conectan...'

Nota clínica importante:

En la primera sesión no se interviene de forma profunda ni interpretativa. No conocemos al paciente, no tenemos alianza establecida y no tenemos suficiente información clínica todavía.

A veces la ansiedad nos gana y queremos devolverle algo al paciente: una interpretación, una explicación, una solución; algo para que se vaya más aliviado o para sentirnos útiles.

Eso es más sobre nuestra incomodidad que sobre lo que el paciente necesita.

La realidad es que la escucha genuina, la presencia y la validación ya son intervenciones en sí mismas. Y son las más poderosas que podés ofrecer en ese primer encuentro.

Las herramientas de esta página — paráfrasis, reflejo emocional, validación, preguntas abiertas son exactamente las intervenciones alineadas a este momento del proceso. Usarlas bien es el trabajo.

9. Dialogos modelo

Como responder en situaciones clave de la primera sesion

SITUACION 1: EL PACIENTE NO SABE POR DONDE EMPEZAR

PACIENTE

No se... hay muchas cosas. No se por donde empezar.

TERAPEUTA

No hay un orden correcto. Podes empezar por lo que mas presente esta para vos hoy, o por lo que te resulte mas facil de contar.

SITUACION 2: EL PACIENTE LLORA Y SE DISCULPA

PACIENTE

Perdon, no queria ponerme asi.

TERAPEUTA

No hay nada que pedir perdon. Este es un espacio para vos y donde lo que sentis es bienvenido. Tomate el tiempo que necesites.

SITUACION 3: EL PACIENTE PREGUNTA SI TENES EXPERIENCIA

PACIENTE

Cuantos años hace que ejerce? Porque yo quiero alguien con experiencia.

TERAPEUTA

Es una pregunta muy valida. Tengo [X] años de practica clinica y trabajo especialmente con [area].

9. Dialogos modelo (continuacion)

Situaciones dificiles en la primera sesion

SITUACION 4: EL PACIENTE HABLA SIN PARAR Y NO DA ESPACIO

PACIENTE

[habla durante 20 minutos sin pausa]

TERAPEUTA

Te quiero frenar un momento porque me parece importante lo que me estas contando. Quiero asegurarme de estar entendiendote bien. Cuando decis que todo se descontroló, a que te referis exactamente?

SITUACION 5: EL PACIENTE HACE PREGUNTAS SOBRE TU VIDA PERSONAL

PACIENTE

Qué opinion tenes sobre esto?

TERAPEUTA

Lo que más nos importa en este momento es entender cómo lo vivís vos. ¿Qué sentís cuando pensás en eso?

SITUACION 6: MENCION DE IDEACION SUICIDA

PACIENTE

A veces pienso que estaria mejor si no estuviera.

TERAPEUTA

Gracias por contarme eso. Necesito entender mejor que me estas diciendo: cuando pensas en no estar, son pensamientos que pasan y se van, o hay momentos en que pensas en hacerte daño?

Ante cualquier mencion de ideacion: siempre explorar. Preguntar directamente no aumenta el riesgo.

10 y 11. El silencio y el cierre

Dos momentos críticos de la primera sesión

10. EL MANEJO DEL SILENCIO

El silencio es parte del lenguaje terapéutico. En la primera sesión aparece con frecuencia y la ansiedad del terapeuta suele llevar a llenarlo rápidamente. Ese error puede interrumpir un proceso interno importante del paciente.

TIPO	QUE SIGNIFICA	QUE HACER
Silencio de procesamiento	El paciente está elaborando algo que acaba de decir o escuchar.	Sostenerlo. No interrumpir. Observar.
Silencio de bloqueo emocional	La emoción es tan intensa que el paciente no puede hablar.	Nombrar con calma: 'Parece que esto es difícil de poner en palabras.'
Silencio de resistencia	El paciente no sabe si puede confiar todavía.	No presionar. Dar permiso de ir despacio.
Silencio de fin de contenido	El paciente terminó de contar y espera.	Reformular o preguntar para profundizar.

11. COMO CERRAR LA PRIMERA SESION

Los últimos 10 minutos de la primera sesión son tan importantes como los primeros. **El cierre da un marco, contiene y prepara al paciente para irse.**

- Avisar que quedan 10 minutos: 'Nos va quedando poco tiempo, quiero aprovechar estos últimos minutos.'
- Hacer un resumen breve y validante de lo que se trabajó.
- Preguntar cómo se fue: 'Como te vas de esta sesión?'
- Si el proceso es apropiado, acordar continuidad: frecuencia, día, modalidad.
- Mencionar el encuadre si no surgió antes: cancelaciones, honorarios.
- Cerrar con un mensaje de reconocimiento por haber venido.

Importante: No abrir temas nuevos y profundos en los últimos 10 minutos. Si el paciente trae algo importante muy al final, nombrarlo y dejarlo para la próxima sesión: "Eso que mencionás me parece muy importante. Lo dejamos como punto de partida para la próxima."

Nota clínica: El silencio incómodo muchas veces puede ser del terapeuta y no del paciente. Cuando sentís el impulso de llenarlo, preguntate primero: ¿esto es por el paciente o por mi propia incomodidad?

12 y 13. Alarmas y errores frecuentes

Señales importantes

12. SEÑALES DE ALARMA A EVALUAR SIEMPRE EN LA PRIMERA SESION

Primero hay que entender una distinción importante:

TIPO A: Se pregunta SIEMPRE. Sin importar el motivo de consulta. Sin importar si el paciente lo menciona o no.

- Ideación suicida: Se pregunta; no hace falta que el paciente lo mencione. Se pregunta en la primera sesión. Preguntar no aumenta el riesgo. Ejemplo: "¿Tuviste pensamientos de no querer estar o de hacerte daño?"
- Consumo de sustancias: Se pregunta siempre, sin tono de juicio. Por qué: El consumo casi siempre aparece minimizado o no se menciona espontáneamente. Cómo: "¿Consumís alcohol u otras sustancias? ¿Con qué frecuencia?"

TIPO B: Se explora si aparece alguna señal, No se pregunta en todos los casos, pero ante cualquier indicador, aunque sea mínimom hay que explorar.

¿Qué es una señal? Una palabra, una frase, una emoción, algo que contó, algo que evitó, algo que notaste en el cuerpo.

AREA	INDICADORES	ABORDAJE
Autolesiones	Menciona hacerse daño, hay marcas visibles, cuenta episodios de crisis	¿Alguna vez te lastimaste para manejar lo que sentías?" Preguntar con calma
Violencia	Miedo a alguien, vínculos muy conflictivos, frases como "me controla", "tengo miedo de volver"	Crear un espacio seguro para que el paciente pueda expresar sobre esa situación y si hay peligro.
Síntomas psicóticos	Discurso desorganizado, menciona experiencias inusuales, saltos ilógicos en el relato	Explorar con curiosidad. Evaluar derivación si es necesario.
Urgencia clínica	Crisis activa, duelo muy reciente, trauma sin elaborar, llanto sostenido desde el inicio	Priorizar contención sobre evaluación. Los datos pueden esperar.
Red de apoyo ausente	Menciona estar completamente solo, sin nadie con quien hablar, aislamiento social marcado	Registrarlo como dato relevante para el proceso. No intentar "solucionar" en la primera sesión.
Duelo reciente	Menciona una pérdida reciente (persona, relación, trabajo, identidad) aunque lo minimice	Dar espacio e intentar explorar sin apresurarse a "resolver": "¿Cómo lo estás llevando?"

13. ERRORES FRECUENTES EN LA PRIMERA SESION

- Creer que el silencio del paciente es un problema que hay que resolver
- Asumir que el motivo de consulta declarado es el motivo real sin explorar más
- No registrar nada de la sesión: ni hipótesis, ni observaciones, ni lo que quedó pendiente para la próxima
- Comparar la experiencia del paciente con la de otros pacientes o con la propia
- Cerrar la sesión sin preguntar cómo se va el paciente

Nota clínica: Los errores más frecuentes en la primera sesión no suelen venir de falta de conocimiento. Vienen de la ansiedad. La ansiedad de hacer bien las cosas, de no quedarse sin qué decir, de no tolerar el silencio, de querer que el paciente se vaya mejor de como llegó. Reconocer esa ansiedad y no actuar desde ella es en sí mismo un trabajo clínico.

14 y 15. Adultos / Infanto-juvenil y Checklist

Diferencias clave y lista de verificación

14. DIFERENCIAS ENTRE PRIMERA SESION CON ADULTOS Y CON NIÑOS/ADOLESCENTES

ASPECTO	ADULTOS	INFANTO-JUVENIL
Quien consulta	El paciente decide y viene por iniciativa propia.	Variable: Pueden ser los cuidadores quienes consulten u otra entidad. El niño/adolescente puede llegar sin querer estar o sin saber por qué
Motivo de consulta	Relatado por el propio paciente.	Doble relato: el del cuidador y el del niño/adolescente. Pueden no coincidir.
Exploracion	Entrevista verbal directa.	En niños: dibujo, actividades. En adolescentes: Mix entre entrevista y actividades
Vinculo inicial	Con el paciente directamente.	Con el cuidador y con el niño/adolescente. Dos alianzas distintas
Confidencialidad	Obligatorio: considera limites como el riesgo de vida para sí mismo o para terceros.	Explicar limites desde el principio: que se comparte y que no.
Evaluacion de riesgo	Con el paciente.	Siempre triangular con cuidadores para verificar seguridad. El niño/adolescente puede minimizar o no reconocer el riesgo

15. CHECKLIST DE LA PRIMERA SESION

- ☐ Recibir al paciente con calidez y sin apuro
- ☐ Explicar el encuadre (duracion, honorarios, politica de cancelación)
- ☐ Dar espacio para que el paciente empiece a su ritmo
- ☐ Usar escucha activa como herramienta principal
- ☐ Validar la experiencia del paciente antes de explorar
- ☐ Explorar el motivo de consulta latente (no solo el declarado)
- ☐ Evaluar riesgo ante cualquier indicador
- ☐ Cerrar la sesion con resumen y pregunta de cierre
- ☐ Acordar continuidad si el proceso lo permite
- ☐ Registrar lo trabajado despues de la sesion
- ☐ Anotar lo que queda por explorar en la proxima sesion

IMPORTANTE EN LAS PRIMERAS SESIONES:

A. El encuadre terapeutico

Que es, para que sirve y como comunicarlo

QUE ES EL ENCUADRE Y POR QUE IMPORTA

El encuadre es el conjunto de condiciones bajo las cuales se desarrolla el proceso terapeutico. Es la estructura que hace posible el trabajo clinico. Un encuadre claro genera confianza y previsibilidad.

ELEMENTO	QUE INCLUYE
Frecuencia	Semanal, quincenal u otra. Definirla y sostenerla es parte del tratamiento. Todo implica flexibilidad: si el paciente mejora se puede pasar de semanal a quincenal, o ajustar según el proceso. Lo importante es que cualquier cambio se hable y se acuerde; no que simplemente suceda.
Duracion de la sesion	Generalmente 50 minutos. El tiempo fijo es parte del encuadre.
Honorarios	El monto, la forma de pago y el momento (inicio o fin de sesion).
Politica de cancelaciones	Con cuantas horas de anticipacion se avisa. Que pasa si no se avisa.
Modalidad	Presencial, online o mixta.
Confidencialidad	Total, salvo riesgo de vida para si mismo o terceros.
Comunicacion entre sesiones	Si hay mensajes, llamadas, como se manejan y con que limites.

CÓMO COMUNICARLO

- Integrarlo en la conversacion. Por ejemplo, cuando surge el tema de los horarios, explicar la politica de cancelaciones. Cuando se habla de como va a ser el trabajo, explicar la frecuencia y duracion.
- Clave: presentarlo como parte del cuidado del espacio

Nota importante — El encuadre flexible no es encuadre ausente

Cuando empezamos a atender, muchas veces nos da miedo que el paciente se enoje o abandone el tratamiento. Eso nos lleva a ser demasiado flexibles con las cancelaciones, los honorarios, los cambios de horario. El problema es que esa flexibilidad sin límites termina perjudicando a las dos partes.

El paciente al que se le perdona cada cancelación sin cobrar entiende que esa es la forma de trabajar. Y después sostener el encuadre se vuelve mucho más difícil.

La flexibilidad es necesaria y es parte del trabajo clínico. Pero hay una diferencia enorme entre flexibilidad con encuadre y ausencia de encuadre.

No es lo mismo:

— Que el paciente cancele y no decir nada

— Que el paciente cancele y sostener el encuadre con calidez: "Entiendo que fue un imprevisto. Recordá que para la próxima necesito que me avises con anticipación, porque sino la sesión se abona igual. Esta vez podemos reprogramar."

IMPORTANTE EN LAS PRIMERAS SESIONES:

B. Honorarios y cancelaciones

Cómo manejarlo

POR QUE HABLAR DE HONORARIOS NO ES SOLO ADMINISTRATIVO

Como el terapeuta cobra, sostiene el arancel y maneja las ausencias comunica algo sobre el encuadre, el valor del espacio y el cuidado de si mismo como profesional.

COMO COMUNICAR EL ARANCEL

Con claridad

'El honorario por sesion es de \$____.'

No agregar justificaciones. Si hay duda sobre si puede pagarlo, eso se conversa

CUANDO COMUNICARLO

Antes de la primera sesion

En el contacto inicial o al acordar el turno

POLITICA DE CANCELACIONES — COMO DEFINIRLA Y SOSTENERLA

- Definir con cuantas horas de anticipacion se puede cancelar sin costo (habitualmente 24 o 48 hs).
- Comunicarlo en la primera sesion, de forma natural, como parte del encuadre.
- Sostenerlo aunque incomode: cobrar la sesion no avisada es parte del encuadre acordado.
- Si el paciente cancela seguido, es material clinico y es necesario poder conversarlo en sesión

¿Qué pasa si el paciente dice que no puede pagar ese monto?

Eso se conversa. Hay opciones: acordar un arancel diferenciado, definir una frecuencia menor, o reconocer que en este momento no es la modalidad adecuada y orientarlo a otro recurso. Lo que no conviene es bajar el precio sin hablarlo, de forma implícita, por incomodidad.

¿Cuándo y cómo ajustar el arancel?

Si decidís actualizar honorarios, comunicarlo con anticipación, al menos una sesión antes. "A partir del mes que viene el honorario va a ser de \$____. Te aviso con tiempo para que puedas organizarte. Cualquier duda o inconveniente avisame"

El pago atrasado o incompleto

Si un paciente debe sesiones, nombrarlo. No dejarlo acumula. Por ejemplo "Recordá que es necesario mantener al día los pagos de las sesiones para poder continuar con el proceso de forma adecuada."

IMPORTANTE EN LAS PRIMERAS SESIONES:

C. Objetivos y plan de tratamiento

Cuando, como y para que establecerlos

CUANDO SE ESTABLECEN LOS OBJETIVOS TERAPEUTICOS

Los objetivos terapeuticos se construyen en las primeras sesiones, cuando ya hay suficiente informacion clinica y alianza como para pensar juntos hacia donde ir.

COMO CONSTRUIR OBJETIVOS CON EL PACIENTE, NO PARA EL PACIENTE

- Partir de lo que el paciente trae, no de lo que el terapeuta diagnostica.
- Usar el lenguaje del paciente: si el dice 'quiero sentirme menos agobiado', ese es el punto de partida.
- Distinguir objetivos de proceso (lo que se trabaja en sesion) de objetivos de resultado (lo que quiere lograr en su vida).
- Hacerlos concretos y revisables: 'trabajar la ansiedad' es muy amplio. '¿Que cambiaria en tu vida si la ansiedad fuera menor?' orienta mejor.
- Revisarlos periodicamente: los objetivos pueden cambiar a medida que avanza el proceso.

EL PLAN DE TRATAMIENTO BASICO

QUE INCLUYE

- Motivo de consulta formulado clinicamente
- Hipotesis diagnostica preliminar
- Objetivos acordados con el paciente
- Estrategias y herramientas previstas

PARA QUE SIRVE

- Orientar el trabajo sesion a sesion
- Tener un norte ante momentos de incertidumbre
- Material para supervision o interconsulta
- Evaluar progreso a lo largo del tiempo

Por qué importa tener objetivos claros

Los objetivos no son solo un punto de partida: son una brújula a lo largo de todo el proceso. Una intervención sin objetivo es una intervención al azar. Cuando tenés claro hacia dónde va el proceso, cada intervención tiene un criterio clínico detrás.

Tipos de objetivos (no todos los pacientes buscan lo mismo):

Antes de definir objetivos, es importante entender qué espera el paciente del proceso. Hay pacientes que buscan un espacio catártico (hablar, ser escuchados, desahogarse); otros buscan cambios concretos en su vida, otros llegan sin saber qué esperan (y será parte del proceso construir objetivos en conjunto)

Esa expectativa es el punto de partida para construir los objetivos juntos.

Los objetivos tienen que ser medibles

"Trabajar la ansiedad" no es un objetivo medible. Estas preguntas ayudan a concretarlo:

¿Qué cambiaría en tu vida si este problema fuera menor? ¿Cómo te darías cuenta de que estás mejor? ¿Qué estarías haciendo diferente? Esas respuestas son los indicadores de progreso.

Revisarlos periódicamente

Los objetivos pueden cambiar a lo largo del proceso. Pueden haberse cumplido y necesitar nuevos. Puede aparecer algo más urgente que los desplace. Revisarlos es parte del trabajo clínico

Algunas señales de que vale la pena revisar:

- El paciente ya no sabe por qué viene
- Las sesiones se volvieron repetitivas sin avance
- El motivo de consulta original cambió
- El paciente menciona que "ya está mejor" pero sigue viniendo sin un norte claro

Guía Completa:

PARTE 2: DOCUMENTOS Y PLANTILLAS

Lic Agustina Rey

Recursos listos para imprimir y usar en la práctica clínica

quieroterapia.com.ar

**Recurso para
profesionales**

Historia clinica · Primera entrevista

Psicología clinica · Uso profesional confidencial

NOMBRE Y APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE PRIMERA SESION

DNI / IDENTIFICACION

TELEFONO DE CONTACTO

EMAIL

DERIVADO POR / COMO LLEGO

MODALIDAD (PRESENCIAL / ONLINE)

DOMICILIO / LOCALIDAD

MOTIVO DE CONSULTA

(En palabras del paciente)

QUE LO TRAE HOY / COMO LO FORMULA

HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL

DESDE CUANDO (INICIO APROXIMADO)

QUE LO DESENCADENO / PRECIPITANTE

COMO EVOLUCIONO HASTA HOY

INTENTOS DE SOLUCION Y TRATAMIENTOS PREVIOS

QUE HIZO HASTA AHORA / SI TUVO TERAPIA PREVIA Y COMO FUE

Historia clinica · Primera entrevista (continuacion)

CONTEXTO ACTUAL

SITUACION LABORAL / ESTUDIANTIL

ESTADO CIVIL / CONVIVENCIA

RED DE APOYO: CON QUIEN CUENTA, VINCULOS SIGNIFICATIVOS

EVALUACION DE RIESGO

Ideacion suicida (SI / NO / explorar)

Autolesiones (SI / NO / explorar)

Consumo de sustancias (SI / NO / cual)

Situaciones de violencia (SI / NO)

OBSERVACIONES CLINICAS · PRIMERA IMPRESION

ESTADO DE ANIMO, PRESENTACION, DISCURSO, CONTACTO, POSTURA, OBSERVACIONES RELEVANTES

HIPOTESIS DIAGNOSTICA PRELIMINAR

PRIMERA HIPOTESIS (FLEXIBLE Y REVISABLE)

PLAN Y PROXIMOS PASOS

FRECUENCIA ACORDADA

PROXIMO TURNO

OBJETIVOS PRELIMINARES / FOCO DE TRABAJO INICIAL

Recurso para profesionales

Diario de sesion

Para registrar despues de cada sesion · Uso personal de la terapeuta

PACIENTE

FECHA Y NUMERO DE SESION

QUE TRAJO EL PACIENTE HOY

TEMAS, EMOCIONES, NARRATIVAS RELEVANTES

INTERVENCIONES QUE REALICE

QUE HICE, QUE TECNICA O HERRAMIENTA USE, COMO RESPONDO EL PACIENTE

QUE OBSERVE (CLINICAMENTE)

ESTADO EMOCIONAL, DISCURSO, CAMBIOS RESPECTO A SESIONES ANTERIORES, LENGUAJE CORPORAL

LO QUE ME GENERO A MI

CONTRATRANSFERENCIA: QUE SENTI, QUE ME MOVILIZO, QUE PENSE QUE QUEDO RESONANDO

DUDAS Y PUNTOS A LLEVAR A SUPERVISION

QUE NO SUPE COMO MANEJAR / QUE QUIERO CONSULTAR

PROXIMOSPASOS Y OBJETIVO PARA LA PROXIMASESION

PENDIENTE A TRABAJAR EN LA PROXIMA SESION / TAREA DEJADA AL PACIENTE

Planilla de seguimiento sesion a sesion

INICIO DEL PROCESO

Plantilla 4 · Seguimiento

Guía de preguntas para la primera entrevista

es un mapa de orientacion

Estas preguntas no son un guion a seguir. Son orientaciones para que nada importante quede sin explorar. Usar con flexibilidad, segun el ritmo del paciente.

APERTURA Y ENCUADRE

- ? ¿Por donde quieres empezar?
- ? ¿Que te trajo hoy aca?
- ? ¿Como llegaste a la decision de venir?

MOTIVO DE CONSULTA

- ? ¿Podes contarme mas sobre lo que te pasa?
- ? ¿Desde cuando te esta pasando esto?
- ? ¿Hay algo que lo haya desencadenado o que lo haya empeorado?
- ? ¿Como afecta esto tu vida cotidiana?

HISTORIA Y ANTECEDENTES

- ? ¿Hiciste terapia antes? ¿Como fue esa experiencia?
- ? ¿Ya te paso algo parecido en otra etapa de tu vida?
- ? ¿Estas tomando algun medicamento o haciendo algun tratamiento?

RED DE APOYO Y CONTEXTO

- ? ¿Con quien contas si las cosas se ponen dificiles?
- ? ¿Como estan tus vinculos mas cercanos en este momento?
- ? ¿Hay cambios importantes en tu vida ultimamente?

EVALUACION DE RIESGO

- ? ¿Tuviste pensamientos de hacerte daño o de no querer estar?
- ? ¿Consumis o consumias alcohol u otras sustancias? ¿Con que frecuencia?
- ? ¿Hay algo en tu vida actual que te haga sentir en peligro?

EXPECTATIVAS Y CIERRE

- ? ¿Que esperas que pasara si la terapia funciona?
- ? ¿Hay algo importante que no te pregunte y quieras contarme?
- ? ¿Como te vas de esta sesion?

Guia Completa:

PARTE 3: OTROS RECURSOS

Lic Agustina Rey

Recursos listos para imprimir y usar en la practica clinica

quieroterapia.com.ar

**Recurso para
profesionales**

Entrevista Inicial

Psicoterapia individual · Adultos

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

GÉNERO

OCUPACIÓN / ESTUDIOS

ESTADO CIVIL

TELÉFONO

EMAIL

2. MOTIVO DE CONSULTA

¿QUÉ TE HIZO BUSCAR TERAPIA AHORA?

¿QUÉ ESTÁ PASANDO QUE TE PREOCUPA / DUELE / DESBORDA?

¿DESDE CUÁNDO?

¿QUÉ INTENTASTE HACER HASTA AHORA?

¿QUÉ ESPERÁS DEL PROCESO TERAPÉUTICO?

3. HISTORIA DEL PROBLEMA ACTUAL

¿CÓMO COMENZÓ? (EVENTO O SITUACIÓN DESENCADENANTE)

¿CON QUÉ FRECUENCIA OCURRE?

¿QUÉ EMOCIONES PREDOMINAN?

¿SEÑALES FÍSICAS?

¿QUÉ PENSAMIENTOS APARECEN EN ESOS MOMENTOS?

¿QUÉ CONDUCTAS REALIZÁS ANTE ESO? (EVITAR, EXPLOTAR, AISLARTE...)

Primera Entrevista con Padres

Anamnesis · Evaluación del sistema familiar

DATOS DEL PACIENTE Y CUIDADORES

NOMBRE DEL NIÑO/A

FECHA DE NACIMIENTO / EDAD

CUIDADORES PRESENTES EN LA ENTREVISTA

FECHA

1. MOTIVO DE CONSULTA

¿QUÉ LOS TRAE? (EN PALABRAS DE LOS PADRES)

¿DESDE CUÁNDO LO OBSERVAN? ¿QUÉ CAMBIÓ?

CONSULTAS PREVIAS Y RESULTADO

EXPECTATIVAS DEL TRATAMIENTO

2. ANAMNESIS — HISTORIA DEL DESARROLLO

EMBARAZO Y PARTO

— ¿Fue buscado? ¿Complicaciones? ¿Tipo de parto?

PRIMEROS AÑOS

— Vínculo temprano, lactancia, separaciones, quién cuidaba al niño

HITOS DEL DESARROLLO

— ¿Cuándo caminó, habló, controló esfínteres? ¿Algo llamó la atención?

HISTORIA MÉDICA

— Enfermedades, internaciones, cirugías, medicación actual

HISTORIA ESCOLAR

— Adaptación, cambios de escuela, relación con docentes y pares

HISTORIA FAMILIAR

— Separaciones, mudanzas, pérdidas, antecedentes de salud mental

SITUACIÓN ACTUAL

— ¿Cómo es un día típico? Rutinas, sueño, alimentación, juego

CONSULTAS PREVIAS

— ¿Tuvieron otras consultas psicológicas? ¿Con qué resultado?

Primera Entrevista con Padres

Anamnesis · Evaluación del sistema familiar

3. CONTEXTO ESCOLAR Y SOCIAL

DESEMPEÑO ACADÉMICO ACTUAL

RELACIÓN CON DOCENTES

RELACIÓN CON PARES

DIFICULTADES REPORTADAS POR LA ESCUELA

4. DINÁMICA FAMILIAR

COMPOSICIÓN DEL HOGAR

RELACIÓN NIÑO–PADRES (DESCRIPCIÓN)

CONFLICTOS RECURRENTES EN CASA

CAMBIOS FAMILIARES RECIENTES

5. QUÉ OBSERVAR EN LOS PADRES

- Cómo hablan del niño/a: ¿con afecto, preocupación, agotamiento, rechazo?
- Atribuciones: ¿a qué le atribuyen el problema? ¿Al niño, a la escuela, a sí mismos?
- Expectativas: ¿son realistas respecto al proceso terapéutico?
- Dinámica de pareja: ¿están de acuerdo? ¿Hay conflicto abierto sobre el niño?
- Disponibilidad: ¿pueden comprometerse? ¿Tienen limitaciones?

6. IMPRESIÓN CLÍNICA Y PRÓXIMOS PASOS

HIPÓTESIS DIAGNÓSTICAS PRELIMINARES

EVALUACIONES / INTERCONSULTAS A REALIZAR

ENCUADRE ACORDADO CON LA FAMILIA

PRÓXIMA CITA

■ *No tomar partido ni emitir juicios en la primera entrevista. Validar la preocupación parental siempre.*

Primera Entrevista · Adolescente

Guía de exploración clínica individual

DATOS

INICIALES / NOMBRE

EDAD

FECHA

¿SABE POR QUÉ VIENE?

¿FUE IDEA PROPIA O DE UN ADULTO?

1. APERTURA Y ENCUADRE

Explicar: confidencialidad, para qué sirve venir, excepción de riesgo.

REACCIÓN AL ENCUADRE (COLABORADOR / DESCONFIADO / INDIFERENTE)

2. EXPLORACIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA

"¿Hay algo que te esté complicando la vida? · ¿Qué te gustaría que cambiara?"

PROBLEMA DESDE SU PERSPECTIVA

DIFERENCIAS CON EL RELATO DE LOS ADULTOS

3. CONTEXTO ESCOLAR Y SOCIAL

VÍNCULO CON PARES

VÍNCULO CON DOCENTES

ACTIVIDADES QUE DISFRUTA / QUE YA NO HACE

4. MUNDO EMOCIONAL Y AFRONTAMIENTO

"¿Cómo te sentís la mayor parte del tiempo? · ¿Qué hacés cuando te sentís muy mal?"

VOCABULARIO EMOCIONAL DISPONIBLE

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

TOLERANCIA AL MALESTAR (B/M/A)

IMPULSIVIDAD (B/M/A)

ESTADO DE ÁNIMO PREDOMINANTE

5. CONTEXTO FAMILIAR Y VÍNCULOS

FIGURA DE REFERENCIA / APOYO

CONFLICTOS VINCULARES RELEVANTES

CAMBIOS FAMILIARES RECIENTES

6. OBSERVACIONES CLÍNICAS

ACTITUD (COLABORADOR / INHIBIDO / OPOSITOR)

CALIDAD DEL VÍNCULO INICIAL

HIPÓTESIS CLÍNICAS PRELIMINARES

Historia Clínica

Registro clínico · Datos de historia de vida

DATOS DEL PROFESIONAL

NOMBRE COMPLETO

MATRÍCULA / COLEGIATURA

EMAIL

TELÉFONO DE CONTACTO

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

GÉNERO

ESTADO CIVIL

OCUPACIÓN

TELÉFONO

EMAIL

OBRA SOCIAL / MUTUAL

AFILIADO N°

DOMICILIO

FECHA DE ADMISIÓN

MOTIVO DE CONSULTA

MOTIVO APARENTE

DERIVACIÓN

PROFESIONAL QUE DERIVA

ANTECEDENTES Y EXPLORACIÓN DIAGNÓSTICA

SINTOMATOLOGÍA ACTUAL

ANTECEDENTES DE SALUD MENTAL (PROPIOS Y FAMILIARES)

TERAPIAS O INTERVENCIONES PREVIAS

MEDICACIÓN ACTUAL

PROFESIONAL QUE PRESCRIBE

Historia Clínica

Registro clínico · Datos de historia de vida

GENOGRAMA Y GRUPO FAMILIAR

Dibujar genograma · anotar referencias

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO

DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO

CÓDIGO CIE-10 / DSM

INDICADORES DIAGNÓSTICOS

PRUEBAS ADMINISTRADAS

PRUEBA 1

FECHA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME / RESULTADOS

PRUEBA 2

FECHA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME / RESULTADOS

PRUEBA 3

FECHA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME / RESULTADOS

Evaluación de Riesgo · Adultos

Protocolo de evaluación clínica — uso exclusivo del profesional

PACIENTE / INICIALES

SESIÓN N°

FECHA

EVALUACIÓN DE IDEACIÓN SUICIDA

- ☐ Presencia de ideación pasiva ("quisiera no estar", "estaría mejor muerto/a")
- ☐ Ideación activa sin plan específico *pensamientos recurrentes de suicidio*
- ☐ Plan elaborado *método, lugar, momento definidos*
- ☐ Acceso a medios letales *armas, medicamentos, otros*

INTENTOS PREVIOS (FECHA, MÉTODO, RESCATE)

INTENSIDAD ESTIMADA (0–10)

FRECUENCIA DE LOS PENSAMIENTOS

DURACIÓN DE LOS EPISODIOS

FACTORES DE RIESGO

- ☐ Historia de intentos previos propios o familiares
- ☐ Acceso a medios letales en el hogar
- ☐ Abuso de sustancias activo
- ☐ Aislamiento social severo
- ☐ Pérdida reciente significativa (duelo, ruptura, trabajo)
- ☐ Historial de trauma o abuso
- ☐ Trastorno mental severo no tratado
- ☐ Impulsividad alta

AUTOLESIONES (SIN INTENCIÓN SUICIDA)

- ☐ Presencia de conductas autolesivas actuales

TIPO / MÉTODO

FRECUENCIA / ÚLTIMA VEZ

FUNCIÓN (REGULACIÓN / COMUNICACIÓN)

FACTORES PROTECTORES

- ☐ Red de apoyo familiar o social significativa
- ☐ Vínculo terapéutico establecido
- ☐ Razones para vivir claramente expresadas
- ☐ Proyectos o metas a futuro
- ☐ Habilidades de afrontamiento disponibles
- ☐ Ausencia de acceso a medios letales

DECISIÓN CLÍNICA Y PLAN DE ACCIÓN

NIVEL DE RIESGO (BAJO / MODERADO / ALTO)EVALUADORA

FECHA

ACCIONES TOMADAS EN SESIÓN

PLAN DE SEGURIDAD ACORDADO

Evaluación de Riesgo · Adolescentes

Protocolo de evaluación clínica — uso exclusivo del profesional

INICIALES / NOMBRE

EDAD

SESIÓN N° / FECHA

EVALUACIÓN DE IDEACIÓN SUICIDA

- | | |
|---|---|
| ☐ Ideación pasiva | "quisiera no estar", "estaría mejor muerto/a" |
| ☐ Ideación activa sin plan | pensamientos recurrentes de suicidio |
| ☐ Plan elaborado | método, lugar y momento definidos |
| ☐ Acceso a medios letales | armas, medicamentos, objetos cortantes |

INTENTOS PREVIOS (FECHA, MÉTODO, RESCATE)

INTENSIDAD ESTIMADA (0–10)

FACTORES DE RIESGO

- | | |
|--|---|
| ☐ Historia de intentos previos propios o familiares | ☐ Rechazo o acoso por pares (bullying) |
| ☐ Acceso a medios letales en el hogar | ☐ Antecedente de autolesiones |
| ☐ Abuso de sustancias activo | ☐ Impulsividad alta |
| ☐ Aislamiento social severo | ☐ Trastorno mental severo no tratado |
| ☐ Pérdida reciente significativa | ☐ Violencia en el hogar |

AUTOLESIONES (SIN INTENCIÓN SUICIDA)

- ☐ Presencia de conductas autolesivas actuales

TIPO / MÉTODO

FRECUENCIA / ÚLTIMA VEZ

FUNCIÓN

OTRAS ÁREAS DE RIESGO

- ☐ Consumo problemático de sustancias
- ☐ Conductas sexuales de riesgo
- ☐ Conductas agresivas hacia otros
- ☐ Situación de vulnerabilidad (negligencia, abuso)
- ☐ Conflictos familiares severos

FACTORES PROTECTORES

- | | |
|--|---|
| ☐ Red de apoyo familiar significativa | ☐ Proyectos / metas a futuro |
| ☐ Vínculo terapéutico establecido | ☐ Habilidades de afrontamiento disponibles |
| ☐ Razones para vivir expresadas | |

DECISIÓN CLÍNICA Y PLAN DE ACCIÓN

NIVEL DE RIESGO (BAJO / MODERADO / ALTO)

FECHA

ACCIONES TOMADAS Y PLAN DE SEGURIDAD ACORDADO

CONTACTO CON ADULTO REFERENTE / FAMILIA

Conceptualización de Caso

Formulación clínica ·

PACIENTE / INICIALES

FECHA

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

MOTIVO DE CONSULTA EN PALABRAS DEL PACIENTE

CONDUCTAS PROBLEMA (EXCESOS Y DÉFICITS)

FRECUENCIA / INTENSIDAD / DURACIÓN

CONTEXTOS DE ACTIVACIÓN

2. FACTORES PREDISPONENTES (HISTORIA)

ANTECEDENTES RELEVANTES: HISTORIA DE VIDA, VÍNCULOS TEMPRANOS, TRAUMA

3. FACTORES PRECIPITANTES

¿QUÉ DESENCADENÓ EL PROBLEMA ACTUAL? EVENTOS, CAMBIOS, PÉRDIDAS

4. FACTORES DE MANTENIMIENTO

PENSAMIENTOS / CREENCIAS QUE SOSTIENEN EL PROBLEMA

CONDUCTAS DE EVITACIÓN O ESCAPE QUE MANTIENEN EL CICLO

FACTORES AMBIENTALES / INTERPERSONALES DE MANTENIMIENTO

Conceptualización de Caso

Formulación clínica ·

5. CREENCIAS NUCLEARES Y ESQUEMAS

CREENCIAS NUCLEARES IDENTIFICADAS (SOBRE SÍ MISMO, EL MUNDO, EL FUTURO)

CREENCIAS INTERMEDIAS / REGLAS / SUPUESTOS

6. FACTORES PROTECTORES Y RECURSOS

FORTALEZAS Y RECURSOS INTERNOS DEL PACIENTE

RED DE APOYO DISPONIBLE

MOTIVACIÓN PARA EL CAMBIO / VALORES CENTRALES

7. HIPÓTESIS INTEGRADORA

INTEGRACIÓN DE LOS FACTORES EN UNA NARRATIVA CLÍNICA COHERENTE

8. IMPLICANCIAS PARA EL TRATAMIENTO

FOCOS TERAPÉUTICOS PRIORITARIOS

TÉCNICAS E INTERVENCIONES A USAR

POSIBLES OBSTÁCULOS O DIFICULTADES PREVISTAS

■ *La conceptualización es una hipótesis en construcción. Revisarla y actualizarla a lo largo del proceso terapéutico.*

Objetivos Terapéuticos

Registro del profesional · Formulación de metas

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE

DNI

FECHA DE ADMISIÓN

DIAGNÓSTICO / FORMULACIÓN

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

MOTIVO DE CONSULTA

PROBLEMA PRESENTADO EN PALABRAS DEL PACIENTE

¿QUÉ ESPERA DE LA TERAPIA?

METAS DEL PACIENTE (EN SUS PROPIAS PALABRAS)

META 1

META 2

META 3

META 4

OBJETIVOS CLÍNICOS DEL TERAPEUTA

CORTO PLAZO (1–3 MESES)

MEDIANO PLAZO (3–6 MESES)

LARGO PLAZO (6+ MESES)

INDICADORES DE PROGRESO

¿CÓMO SABREMOS QUE SE ESTÁN LOGRANDO LOS OBJETIVOS?

Plan de Tratamiento

Registro del profesional

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE

DNI

FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO CIE-10

DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN CLÍNICA

FORMULACIÓN DEL CASO

ENFOQUE TERAPÉUTICO

- | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| ☐ TCC | ☐ ACT / Aceptación | ☐ DBT | ☐ Sistémico |
| ☐ Psicodinámico | ☐ EMDR | ☐ Humanista / Gestalt | ☐ Otro: |

ENCUADRE TERAPÉUTICO

FRECUENCIA DE SESIONES

DURACIÓN ESTIMADA DEL TRATAMIENTO

DURACIÓN DE CADA SESIÓN

MODALIDAD ☐ Presencial ☐ Online ☐ Mixta

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

Plan de Tratamiento

Registro del profesional

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PLANIFICADAS

INDICADORES DE PROGRESO

¿CÓMO SABREMOS QUE EL TRATAMIENTO ESTÁ SIENDO EFECTIVO?

POSIBLES OBSTÁCULOS Y PLAN DE CONTINGENCIA

DERIVACIONES O INTERCONSULTAS PLANIFICADAS

Profesional / Especialidad	Motivo

OBSERVACIONES DEL PROFESIONAL

FECHA

FIRMA Y SELLO

Seguimiento de Sesiones

Registro clínico del proceso terapéutico

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE

DNI

FECHA (DD/MM/AAAA)	SESIÓN N°	ESTADO EMOCIONAL INICIO → CIERRE (0–10)
TEMA PRINCIPAL DE LA SESIÓN		
RESUMEN DE LO TRABAJADO / TÉCNICA UTILIZADA		
TAREA TERAPÉUTICA PROPORCIONADA		
OBJETIVOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN		

FECHA (DD/MM/AAAA)	SESIÓN N°	ESTADO EMOCIONAL INICIO → CIERRE (0–10)
TEMA PRINCIPAL DE LA SESIÓN		
RESUMEN DE LO TRABAJADO / TÉCNICA UTILIZADA		
TAREA TERAPÉUTICA PROPORCIONADA		
OBJETIVOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN		

FECHA (DD/MM/AAAA)	SESIÓN N°	ESTADO EMOCIONAL INICIO → CIERRE (0–10)
TEMA PRINCIPAL DE LA SESIÓN		
RESUMEN DE LO TRABAJADO / TÉCNICA UTILIZADA		
TAREA TERAPÉUTICA PROPORCIONADA		
OBJETIVOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN		

Checklist Pre-Sesión

Completar antes de recibir al paciente

PACIENTE

FECHA / SESIÓN N°

ANTES DE QUE ENTRE EL PACIENTE

- Revisé mis notas de la sesión anterior
- Revisé la tarea que quedó pendiente
- Tengo claro el objetivo de esta sesión
- El consultorio está ordenado y con privacidad
- Tengo los materiales necesarios listos
- Ajusté el encuadre si hubo cambios recientes

ESTADO DEL PROCESO TERAPÉUTICO

- La alianza terapéutica está activa y sólida
- El/la paciente está cumpliendo con el encuadre
- Los objetivos siguen siendo relevantes
- No hay señales de crisis o riesgo activo sin abordar
- El proceso está avanzando hacia los objetivos planteados

MI ESTADO COMO PROFESIONAL

- Me siento presente y disponible para esta sesión
- No traigo preocupaciones personales que interfieran
- Estoy al tanto de posibles reacciones de contratransferencia
- Tengo claridad sobre el encuadre y los límites

FOCO DE ESTA SESIÓN

¿QUÉ QUIERO PRIORIZAR HOY?

¿HAY ALGO DEL PACIENTE QUE ME GENERA INQUIETUD?

INTERVENCIÓN O TÉCNICA QUE PLANEÓ USAR
